BRIGADE DE SAPEURS POMPIERS DE PARIS

Chutes et relevages en gériatrie

FMA des chefs d'agrès
2025 - 2026



C'est quoi les caractéristiques de la personne âgée en SSUAP ?

- Elle ne veut jamais aller aux urgences ! Et on la comprend !
- Elle a beaucoup de pathologies et de FDR CV.
- Elle n'a plus de muscles, donc moins de force… Elle est dénutrie.
- Elle a les os fragiles, donc elle se fait des fractures facilement.
- Elle peut être dépendante.
- Elle est seule…



Ça veut dire quoi « fortuit » ?

- Ça veut dire « imprévu », qui n'est pas planifié.
- Ainsi, toutes les chutes sont forcément fortuites !
- Dire que la chute est fortuite n'a donc pas d'intérêt et ne donne pas la cause de la chute…
- Souvent, ceux qui utilisent ce terme à propos d'une chute, veulent dire que la chute est mécanique.
- En fait, chez la personne âgée, les chutes mécaniques (par maladresse, à cause de l'environnement) ne sont pas les causes les plus fréquentes !



Qu'est ce qui fait chuter les personnes âgées le plus souvent ?

- Causes cardio-circulatoires : arythmie, embolie pulmonaire, insuffisance cardiaque et OAP, détresse circulatoire, poussée d'HTA…
- Causes respiratoires : infection respiratoire (rhume et virus, grippe, bronchite, pneumonie), détresse respiratoire…
- Causes neurologiques : AIT, AVC, vertiges…
- Pathologies diverses : hypoglycémie ou hyperglycémie, infections, rétention d'urines…
- Effets indésirables des médicaments
- Les causes physiologiques, c'est-à-dire le vieillissement naturel (perte de coordination, diminution de la force musculaire, pathologies des articulations, baisse de la vue…)

La chute mécanique est RARE !

- Ainsi, le motif mécanique est très largement surévalué par les secouristes !
- Ce terme est l'arbre qui cache la forêt : il rassure tout le monde (victime, secouristes, médecins), alors qu'en réalité il n'en est rien !

Que disent les spécialistes ?

- « Les chutes sont très rarement mécaniques chez la personne âgée, et elles doivent être prises en charge comme une affection potentiellement grave, qu'elles qu'en soient les circonstances ! ».
- Plus les personnes âgées chutent, plus elles meurent tôt.
- Chez la personne âgée, rares sont donc les chutes qui peuvent être laissées sur place !

Qu'est ce qu'on entend par « relevage de personne impotente » ?

- Il s'agit de relever une personne qui du fait de l'âge a une faiblesse articulaire et musculaire, mais qui APRÈS bilan ne présente pas de détresse ou de troubles pouvant avoir contribué à la chute.
- Le bilan doit donc s'acharner à rechercher ces éléments.



Qu'est ce que risque une personne âgée qui a chuté ?

- Traumatismes :
  - Fractures, entorses…
  - Plaies
  - Contusions
  - Points de compressions : au bout de quelques heures au sol sans bouger, la personne âgée risque le crush syndrom
- Déshydratation
- Hypothermie
- Décompensation de maladie chronique car pas de prise du traitement







De quels éléments a-t-on besoin pour laisser sur place une personne âgée qui a chuté ?

- Durée courte
- Retour à l'état antérieur (il faut donc demander l'avis de proches qui connaissent la personne âgée !)
- Absence de détresse
- Absence de signes d'AVC, même très légers ou seulement douteux !
- Marche possible
- Absence de conséquence trauma, même minime

- Autonomie habituelle ?
- Entourage ?
- Possibilité de rappeler ?

Cas n°1

Relevage d'une personne impotente

Homme, né le [redacted]/1932 (92 ans)

maison pour personnes âgés // [redacted] // au RDC // H93a // consciente // chute // TC // saignement actif // sous antico

12:10

ANTÉCÉDENTS

Antécédents inconnus : Oui

AUTONOMIE

La victime est autonome dans la vie quotidienne ?

TRAITEMENTS EN COURS

Traitements inconnus : Oui

ALLERGIES

Aucune allergie : Oui

MOTIFS DE RECOURS

Autre traumatisme ou plaies simple non mentionnés ailleurs

BILAN PROMPT-SECOURS

Que s'est-il passé avant l'appel des secours ? : un homme de 92 ans glisse sur sa chaise et se fait mal a la tête

Situation à l'arrivée des secours : BOTE & BMS4M
Monsieur se plaint d'aucune douleur, la chute est accidentelle et mécanique (pas de malaise)

Monsieur ne souhaite pas aller a l'hôpital car rien de grave selon lui - la résidence n'a pas l'autorisation de nettoyer la plaie (nature de l'appel)

PA habituelle ~ 8 et 10

MISE EN CONDITION

Pansement simple : Oui

CIRCULATION

Pouls régulier // Pouls radial perçu

SIGNES

Pas de Signes respiratoires // Pas de Troubles de conscience // Pas de PCI // Pas de Sueurs // Pas de Pâleur cutanée // Pas de Fatigue intense, impossibilité de se lever

PARAMÈTRES VITAUX

	12:24	12:29	12:29
FC	80	80	85
PA BG	87/51	80/54	92/50
FR	18		
SpO2	96 %	95 %	95 %
SpO2 :: Dispositif	Air ambiant	Air ambiant	Air ambiant
Température	36.9 °C		
Glycémie	5.8 mmol/L		
GCS	Y4 V5 M6 (15)		
EVS	0 - Absence de douleur	0 - Absence de douleur	

COMMENTAIRE

Ømalaise / souhaite resté sur place / tension basse habituel / entre 8 et 10 / dans une résidence pour personne âgée

OCM

Médecin

TC en chutant, TA qui serait habituel, => sous anticoagulant, => sous eliquis, refus catégorique LSP



La chute est-elle mécanique ?

Certainement pas ! Il existe une PA basse, c'est probablement la détresse circulatoire qui a fait chuter cette victime...

Peut-on laisser cette victime sur place ?

Certainement pas ! C'est un TC chez une victime qui prend des anticoagulants ! Il y a un risque d'hémorragie intra-crânienne...

Le CA et le médecin CM ont essayé de convaincre la victime d'aller à l'hôpital, mais personne n'a réussi... LSP donc...

Et la suite ?

Détresse vitale 14:10

on attend en bas // etg 3// h80 // acr // massage en cours

MOTIFS DE RECOURS

Arrêt Cardio-Respiratoire

BILAN PROMPT-SECOURS

Que s'est-il passé avant l'appel des secours ? : 1 homme est en acr

Situation à l'arrivée des secours : Infection pulmonaire

non vu depuis 1415
chute a la tête a 1200
découvert 1400 massage par requérant
Massage pompier 1422
1422 pas de choc
6e cycle pas de choc 1431
1440 pas de choc décès prononcé

Cas n°2

Homme, né le [redacted]1953 (72 ans) Relevage d'une personne impotente 22:10

PAV // H 72 // conscient // chute meca // au sol // ne peut pas se relever // femme SLL //

BILAN PROMPT-SECOURS

MOTIFS DE RECOURS

Chute de moins de 3m

Que s'est-il passé avant l'appel des secours ? : un homme de 72 ans au sol depuis 10 minutes environ
il a essayé de se mettre debout mais n'a pas réussi à tenir debout et a été accompagnée au sol par sa femme

n'arrive pas a marcher depuis ce matin

Situation à l'arrivée des secours : a notre arrivé l'homme est au sol et se plaint de aucune douleur
pas de traumatisme

pas de signe d'AVC
pas de perte de connaissance
bien orienté dans le temps et dans l'espace
bonne motricité sensibilité des 4 membres
pas de nausées
pas de vomisements
pupilles réactives symétriques de taille intermédiaire

TRC inférieur a 3 secondes
conjonctives colorées
pas de marbrure
pli cutané

pas de signes de détresses respiratoire

double pontage coronarien suivi avec un cardiologue

marche possible sans aide
ne souhaite pas aller à l'hôpital

CIRCULATION

Pouls radial perçu

SIGNES

Pas de Signes respiratoires // Pas de Troubles de conscience // Pas de PCI //
Pas de Sueurs // Pas de Pâleur cutanée // Pas de Fatigue intense, impossibilité de se lever

ANTÉCÉDENTS

hypertension artérielle - HTA
diabète de type 2 - diabète no DNID
pontage coronarien

TRAITEMENTS EN COURS

Forxiga
GLICLAZIDE
PANTOPRAZOLE
ENTRESTO
JANUMET
LASILIX
XARELTO
BISOPROLOL
INEGY
resitunu

PARAMÈTRES VITAUX

	22:16	22:40
FC	75	76
PA BD	162/83	154/90
FR	16	14
SpO2	95 %	95 %
SpO2 :: Dispositif	Air ambiant	Air ambiant
Température	36.0 °C	
Glycémie	6.1 mmol/L	
GCS	Y4 V5 M6 (15)	

COMMENTAIRE

manque de force depuis ce matin // Øsigne avc // Øsigne de detresse // Ødlr ressentie // plie cutanée (n'a pas bu d'eau)
a réussi a marcher avec les secours // ØTC

OCM

Lors du bilan, le CA dit aussi qu'il a déjà chuté ce matin.

Médecin

circonstances et bilan vu antécédents et paramétres vitaux vus ne souhaite pas pas aller a l'hôpital ok lsp consignes données

Et la suite ?

Relevage d'une personne impotente 01:13

PAV // H 72 // conscient // chute du canapé // au sol // ne peut pas se relever // inter SP tout a l'heure //

MOTIFS DE RECOURS

Relevage
Déficit neurologique, suspicion AIT, AVC

BILAN PROMPT-SECOURS

Que s'est-il passé avant l'appel des secours ? : Un homme de 72 ans est à domicile fait une chute fortuite de son canapé lié a une perte de force dans les jambes depuis ce matin et n'arrive pas a se relever.
Pris en charge pour le même motif par les pompiers vers 22 heures ce jour.

Situation à l'arrivée des secours : Allongé au sol, conscient, orienté.
Depuis ce matin, faiblesse dans les jambes, ne tiens plus debout. Inhabituel.
Pas de douleur. Pas de traumatisme. Pas de plaie.
Bonne motricité et sensibilité des quatre membres.

Depuis ce matin :
Perte de tonus bras gauche, inhabituel.
Ne se souvient pas de l'intervention des pompiers à 22h.
A du mal a trouver ses mots. Desorienté dans le temps.
Sa femme ne le trouve pas dans son état habituel.
Troubles de la vision, inhabituel d'après sa femme.

CIRCULATION

Pouls radial perçu — Pas de Sueurs // Pas de Pâleur cutanée

SIGNES

Pas de Signes respiratoires // Pas de Troubles de conscience // Pas de PCI

Fatigue intense, impossibilité de se lever : Oui

DÉFICIT SENSITIF MOTEUR

Déficit moteur : OuiParalysie faciale : R.A.S**Membres supérieurs : Gauche**Membres inférieurs : R.A.S
Déficit sensitif : Non

PUPILLES

Oeil droit : Myosis
Pupille droite réactive : Non
Oeil gauche : Myosis
Pupille gauche réactive : Non

SIGNES

Troubles de l'équilibre : Oui
Pas de Céphalées // Pas de Convulsions

BILAN SPÉCIFIQUE

Troubles de la parole : Difficulté d'articulation (patate chaude)
Trouble de la vision : Oui
Pas de Vertiges // Pas de Déviation du regard // Pas de Anomalie du champ visuel // Pas de Trouble de l'audition'

Le second CA comprend qu'il existe en fait depuis le matin un problème neurologique à l'origine de la chute : ça n'est PAS une chute mécanique !

Cas n°3

Relevage d'une personne impotente

pav // h 85 ans // conscient // chute dans la salle de bain // Ø blessé // ne peut se relever

Homme, né le [redacted] 1940 (85 ans)

ANTÉCÉDENTS

Antécédents inconnus : Oui

TRAITEMENTS EN COURS

Traitements inconnus : Oui

ALLERGIES

Allergies inconnues : Oui

MOTIFS DE RECOURS

Arrêt Cardio-Respiratoire

BILAN PROMPT-SECOURS

Que s'est-il passé avant l'appel des secours ? : un homme de 85 ans est retrouvé en a
en arrêt cardiorespiratoire par sa conjointe

Situation à l'arrivée des secours : était aux toilettes
la conjointe aurait entendu le bruit d'une chute et l'aurait vu au sol
appel directement des secours
pas de signe de traumatisme
se serait plaint de douleur thoracique ce matin
arrivée de l'équipe médicale a 2200
heure de décès 2207

Que dire de la prise d'appel de l'opérateur ?

Est-ce une chute mécanique ?

Est-ce un « relevage » ?

Quelle est la cause de la chute ?

La chute est-elle sans conséquences ?

Faut-il transporter ?

Cas n°4

Femme, née le [redacted]1935 (90 ans) — **Relevage d'une personne impotente**

f 90 ans - au sol - relevage -

BILAN PROMPT-SECOURS

MOTIFS DE RECOURS

Relevage

Que s'est-il passé avant l'appel des secours ? : une femme de 90 ans a glissée de son fauteuil a son domicile.

Situation à l'arrivée des secours : assise au sol contre son fauteuil.
au sol depuis 30min.
pas de malaise.
pas de douleurs spontanée ni a la palpation.
bonne motricité sensibilité des 4 membres.
bien orienté temps espace
relevage effectué sans difficulté.
sous lunettes 2l/min suite à bpco / sat habituelle a 95%.
serait plus faible depuis quelques jours.
pas de point de compression ni escarre.
pas de signes d'AVC
pas de signes de détresse apparent.
pas de difficulté respiratoire mais présence de glaire et encombrée depuis plusieurs jours.
pas de douleur thoracique.
marche possible.
dans son état habituel selon son mari.
02 montée a 5l/min sous lunettes sat qui ne remonte pas

ANTÉCÉDENTS

thyroïdite
hypertension artérielle - HTA
broncho-pneumopathie chronique obstructive - BPCO

TRAITEMENTS EN COURS

Levothyrox une sodique
VALSARTAN

CIRCULATION

Pouls radial perçu

SIGNES

Fatigue intense, impossibilité de se lever : Oui

Pas de Signes respiratoires // Pas de Troubles de conscience // Pas de PCI // Pas de Sueurs // Pas de Pâleur cutanée

Est-ce une chute mécanique ?

Est-ce un « relevage » ?

Quelle est la cause de la chute ?

La chute est-elle sans conséquences ?

Faut-il transporter ?

PARAMÈTRES VITAUX

	21:37	22:01	22:02	22:03	22:03	22:05	22:07
FC	115	113	112	120	111	118	118
PA BG	138/81	98/52		93/56		105/38	114/61
FR	17						
SpO2	82 %	83 %	80 %	79 %	81 %	86 %	87 %
SpO2 :: Dispositif	Lunettes						
SpO2 :: Débit	4 L/min						
Température	36.1 °C						
GCS	Y4 V5 M6 (15)						

Cas n°5

Né le [redacted]1941 (83 ans)

Personne blessée lieu public (VP, ERP, ...)

sur la place devant // f 84 ans // chute au sol //
Trauma face + bras // Ø deformation //

BILAN PROMPT-SECOURS

MOTIFS DE RECOURS

Autre traumatisme ou plaies simple non mentionnés ailleurs

Que s'est-il passé avant l'appel des secours ? : une femme de 83 ans a fait une chute mécanique sur le marché

Situation à l'arrivée des secours : - pas de PCI // bote // bms des 4 membres // chute mécanique // pas de malaise // douleurs légère au doigt // pas de fracture // légère égratignure // non suturable // pas de TC // pas de vomissement //

CIRCULATION

Pouls régulier // Pouls radial perçu

ANTÉCÉDENTS

hypertension artérielle - HTA

SIGNES

Pas de Signes respiratoires // Pas de Troubles de conscience // Pas de PCI // Pas de Sueurs // Pas de Pâleur cutanée // Pas de Fatigue intense, impossibilité de se lever

PARAMÈTRES VITAUX

	11:32
FC	95
PA BG	105/52
FR	17
SpO2	98 %
SpO2 :: Dispositif	Air ambiant
GCS	Y4 V5 M6 (15)

Est-ce une chute mécanique ?

Quelle est la cause de la chute ?

Est-ce un « relevage » ?

La chute est-elle sans conséquences ?

Faut-il transporter ?




G


G

Cas n°6

Femme, née le [redacted] 1945 (80 ans)

Personne malade lieu privé (domicile, ...)

[redacted] / F 80 ans / chute de son lit / retrouvée au sol / mise ds son lit par fils / pas de traumas / vu par infirmier a 17h / bascule samu

MOTIFS DE RECOURS

Difficulté respiratoire

BILAN PROMPT-SECOURS

Que s'est-il passé avant l'appel des secours ? : une femme de 80 ans chute deux fois dans la journee et se sent mal depuis hier

Situation à l'arrivée des secours : tirage
sat a notre arrivee 90 remonte a 97 en 1min
pas de balancement
pas de cyanose
fr 22
pas de bruits
ne tombe pas d'habitude

pas de signes circu

mhta : cancer gorge : sonde gastrique, pas nouri ce midi

	23:59	00:07
FC	93	91
PA BG	142/76	159/88
FR	22	20
SpO2	90 %	98 %
SpO2 :: Dispositif	Air ambiant	Masque MC
SpO2 :: Débit	9 L/min	9 L/min
Température	37.2 °C	
GCS	Y4 V5 M6 (15)	Y4 V5 M6 (15)

Est-ce une chute mécanique ?

Est-ce un « relevage » ?

Quelle est la cause de la chute ?

La chute est-elle sans conséquences ?

Faut-il transporter ?

Cas n°7

Femme, née le [redacted]/1927 (97 ans)

Personne blessée lieu privé (domicile, ...)

** consciente ** chute ** au sol ** plaie tete ** compression en cours **

BILAN PROMPT-SECOURS

Que s'est-il passé avant l'appel des secours ? : Une femme de 97 ans se lève pour aller au toilette, tombe au sol en revenant.
Ne se souvient plus de la chute

Situation à l'arrivée des secours : Plaie face, avec saignement
Présence de selle au sol, avec saignement
Légère pâleur

Pas de douleurs rachis
Pas de déformation
Pas de sueurs
Pas de douleur thoracique
Pas de signes d'AVC

Bien orienté temps espace
Bonne motricité sensibilité des 4 membres

Vivant seule, autonome

CIRCULATION

Pouls régulier // Pouls radial perçu

MOTIFS DE RECOURS

Hémorragie digestive (hématémèse, rectorragie, maelena)
Autre traumatisme ou plaies simple non mentionnés ailleurs

ANTÉCÉDENTS

hypertension artérielle - HTA
tumeur rénal
tuberculose
embolie pulmonaire - EP
rhumatisme articulaire
saignement digestif
cardiopathie ischémique
stent 2001
stent 2015

TRAITEMENTS EN COURS

UVEDOSE
KARDEGIC
CANDESARTAN
MOVICOL
paracétamol
rectoragie

SIGNES

Pâleur cutanée : Oui

Pas de Signes respiratoires // Pas de Troubles de conscience // Pas de PCI // Conjonctives colorées // Pas de Sueurs // Pas de Nausées // Pas de Vomissements // Pas de Fatigue intense, impossibilité de se lever

BILAN SPÉCIFIQUE PROMPT-SECOURS : CARDIOLOGIQUE

SIGNES

Pas de Sensation de soif exprimée spontanément // Pas de Marbrures

BILAN SPÉCIFIQUE PROMPT-SECOURS : DIGESTIF

EXAMEN

Rectorragie : Autre que traces

Pas de Diarrhée

Est-ce une chute mécanique ?

Est-ce un « relevage » ?

Quelle est la cause de la chute ?

La chute est-elle sans conséquences ?

Faut-il transporter ?

	06:20	06:28	06:28
FC	98		90
PA BG		88/39	101/56
FR			18
SpO2	96 %		95 %
SpO2 :: Dispositif	Air ambiant		
Température			35.8 °C
GCS	Y4 V5 M6 (15)		Y4 V5 M6 (15)

Cas n°8

Homme, né le [redacted]1938 (87 ans)

Secours à victime avec ouverture de porte [redacted] / H 87 ans // chute au sol // déclenchement sans réponse // répond pas au CA

BILAN PROMPT-SECOURS

Que s'est-il passé avant l'appel des secours ? : un homme de 80 ans a chute mécaniquement chez lui il y a 20min

Situation à l'arrivée des secours : chute mécaniquement il y a 20min pas de pci ni de tc, pas de signes de traumatismes marche possible , pas de point de compression ni d'escarres pas de signes d'avc bien orienté dans le temps et l'espace bonne sensibilité et motricité des 4 membres pas de détresses circulatoire ou respiratoires

CIRCULATION

Pouls radial perçu

ANTÉCÉDENTS

vésicule biliaire

FACTEURS DE RISQUE CV

Pas de Tabagisme // Pas de Obésité // Pas de Antécédents familiaux // Pas de Sédentaire

TRAITEMENTS EN COURS

XARELTO
BISOPROLOL
FLUCORTAC

SIGNES

Pas de Signes respiratoires // Pas de Troubles de conscience // Pas de PCI // Pas de Sueurs // Pas de Pâleur cutanée // Pas de Fatigue intense, impossibilité de se lever

	16:42
FC	66
PA BG	123/74
FR	15
SpO2	97 %
Température	36.8 °C
GCS	Y4 V5 M6 (15)

Admettons que la chute soit mécanique.
Quels éléments manquent-ils dans le bilan pour que le médecin coordinateur puisse décider ou non du LSP ?

Conclusion

- La chute mécanique, c'est-à-dire par maladresse, est RARE chez la personne âgée.
- La personne âgée se raccroche à l'idée d'une chute par maladresse car elle ne veut pas aller à l'hôpital, et on la comprend !
- La chute est très souvent est le symptôme d'une maladie qui atteint la personne âgée.
- Les conséquences de la chute sont multiples et fréquentes.
- Ainsi, RARES sont les chutes qu'on peut laisser sur place !
- Pour pouvoir laisser sur place la victime, on a besoin de solides arguments, donc d'un bilan rigoureux.